EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS
N° EGRESO : 86354
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-06-10 11:31:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: ISABEL DEL CARMEN SOTO AGURTO			RUN	: 6.806.144-K
F.Nac	: 13-06-1950	Edad	: 73 AÑOS, 11 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: LOS GUINDOS			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-06-05	Fecha Egreso	: 2024-06-10 11:31:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: DOMICILIO	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I64-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO, NO ESP.COMO HEMORRAGICO

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

-ACV isquémico fronto-mesial (+cíngulo) derecho subagudo
-FA (acenocumarol suspendido en hospitalización actual)
-Anemia moderada, obs 2° a enfermedad crónica
-Hipokalemia resuelta
-Hipertiroxinemia eutiroidea
-Ant: HTA (dificil control) - ICC - ACVi corona radiada derecha 2019 secuelado (hemiparesia espástica BC izquierda) - Anemia microcítica hipocrómica crónica (en estudio en CAE, pendiente EDA) - Deterioro cognitivo mayor vascular (con trastorno conductual -agresividad, desorientación espacial-, familiar refiere inicio posterior a 1° ACV) - mRS 4

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I63-INFARTO CEREBRAL (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

REG, HDN con HTA leve a moderada, FA s/RVR posterior a ajuste de tto, eupneica, afebril, euglicémica, tolera bien régimen papilla, no refiere molestias, tranquila, estable en déficit neurológico.
Exs de lab T3 normal lo que sugiere hipertiroxinemia eutiroidea. ELP N.
AngioTC cerebro y cuello muestra estenosis moderada de ambas ramas de M2 derecha, oculisón de porción proximal de V1 izquierda (termina en PICA), ausencia de representación de ACP izq, lesiones isquémicas agudas y crónicas conocidas sin cambios.
TC cerebro s/c de control sin cambios, suboclusión de ACP izquierda sin infartos agudo relacionado.
En vista de la estabilidad clínica se decide alta a domicilio, TC cerebro s/c ambulatorio en 5-7 días, EDA (solicitada en policlínico de Medicina Interna) y colonoscopía ambulatorias (descarte de lesiones en GI proclives a sangrado una vez reiniciado TACO, en contexto de anemia crónica) y control en policlínico de Neurología en 10-12 días con exs solicitados.

PLAN DE MANEJO:

-Alta a domicilio hoy
-Control ambulatorio en policlínico de Neurología con exs pendientes (EDA, colonoscopía, TC cerebro s/c en 5-7 días)
-IC HODOM para continuar rehabilitación kinésica y fonoaudiológica

-ELP, TSH y T4L en 5-7 días
-Ingreso a programa de Postrados de CESFAM para continuar manejo de patologías crónicas

INDICACIONES AL ALTA

1. -Aspirina 100 mg/día
2. -Atorvastatina 40 mg 2 comp/noche
3. -Carvedilol 25 mg c/12 horas
4. -Amlodipino 10 mg/día
5. -Omeprazol 20 mg/día
6. -Digoxina 0.25 mg 1/2 comp al día Lunes a Viernes
7. -Losartan 50 m/día

EXÁMENES Y RESULTADOS

10/6/24
-Na 141 K 4.1 Cl 108

7/6/24
-Crea 1 MDRD 54.2 Uremia 22
-PCR 23
-Mg 2.3 Na 143 K 3.3 Cl 109
-TSH 1.327 T4L 2.49 T3 103.74

6/6/24
-Alb 3.4
-Crea 1.1 MDRD 48.55 Uremia 26
-AU 6.4
-Ca 8.6 Na 141 K 3.2 Cl 110
-PCR 34.6
-Ferritina 35.4 Cap FT FE 275 Transf 270 Fe 17
-Leu 5600 Hb 9.6 Plaq 317000 Seg 59 VHS 14 Ret 1.9
-TSH 2.94 T4L 2.53
-Folato 17.1
-Procal 0.06

5/6/24
-Glic 132
-Alb 3.8
-Crea 1.1 MDRD 48.55 Uremia 33
-Ca 8.8
-FA 112 BI 0.67 BD 0.13 BT 0.8 GOT 22 GPT 16 GGT 18
-ColT 109 HDL 41 LDL 45 VLDL 23.4 TG 117
-Lact 1.1
-PCR 40.9
-Na 139 K 2.8 Cl 106
-Leu 7500 Hb 9.9 Plaq 321000 Seg 75 VHS 31
-INR 1.08 TTPA 27
-TSH 5.602 T4L 1.45
-B12 326 VitD 38.9
-RPR N/R

OBSERVACIONES:

Ex fco gral
-Perfusión e hidratación N, yug no ing, rash(-)
-Cardiaco: RII 2T no ausculto soplos
-Pulmonar: MP(+), SRA, sin uso de musculatura accesoria
-Abd: BDI, RHA(+), no palpo masas ni visceromegalia
-EE: edema(-), TVP(-), pulsos+/+

Ex neurológico:

-Mental: vigil, orientada en parcial en tiempo, desorientada en espacio, impresiona parcialmente atingente, sin apatía, lenguaje fluente, nomina 3/3, repite frases cortas, comprende órdenes de 4 pasos cruzando linea media con dificultad leve
-PC: CV por amenaza impresiona N, pupilas medias e isocóricas, RFM D/C +/+, MOE N, PFC izq leve, disartria leve, nistagmo(-), úvula central, elevación palatina simétrica, motilidad lingual N, fuerza trapecios M5 der y M0 izq, fuerza ECM M5 bilateral
-Motor: fuerza ESD M5, EID M4, ESI M0 proximal y M1-2 distal, EII M2, RCP extensor bilateral, espasticidad BC izq moderada
-Sensibilidad: algesia impresiona conservada en cara y 4 EE
-Cerebelo: n/e, no entiende instrucción
-Signos meningeos(-)

Saulo Venegas Figueroa
MEDICO TRATANTE
16138950-1

JEFE SERVICIO